Syndrome cérébelleux

DR R.CHENNA

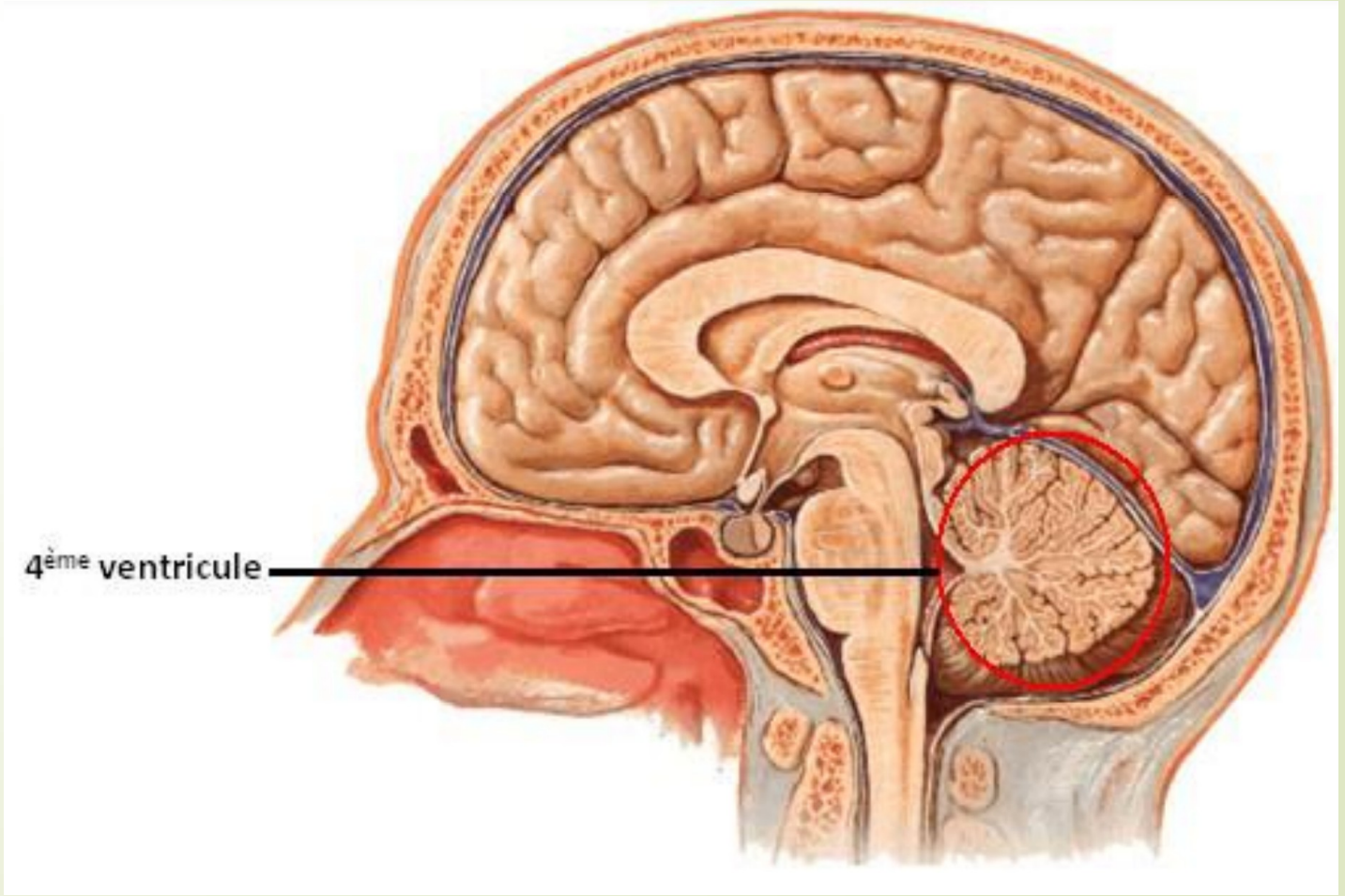
INTRODUCTION

- Ensemble des symptômes et signes résultant d'une atteinte du cervelet lui-même ou des voies cérébelleuses.

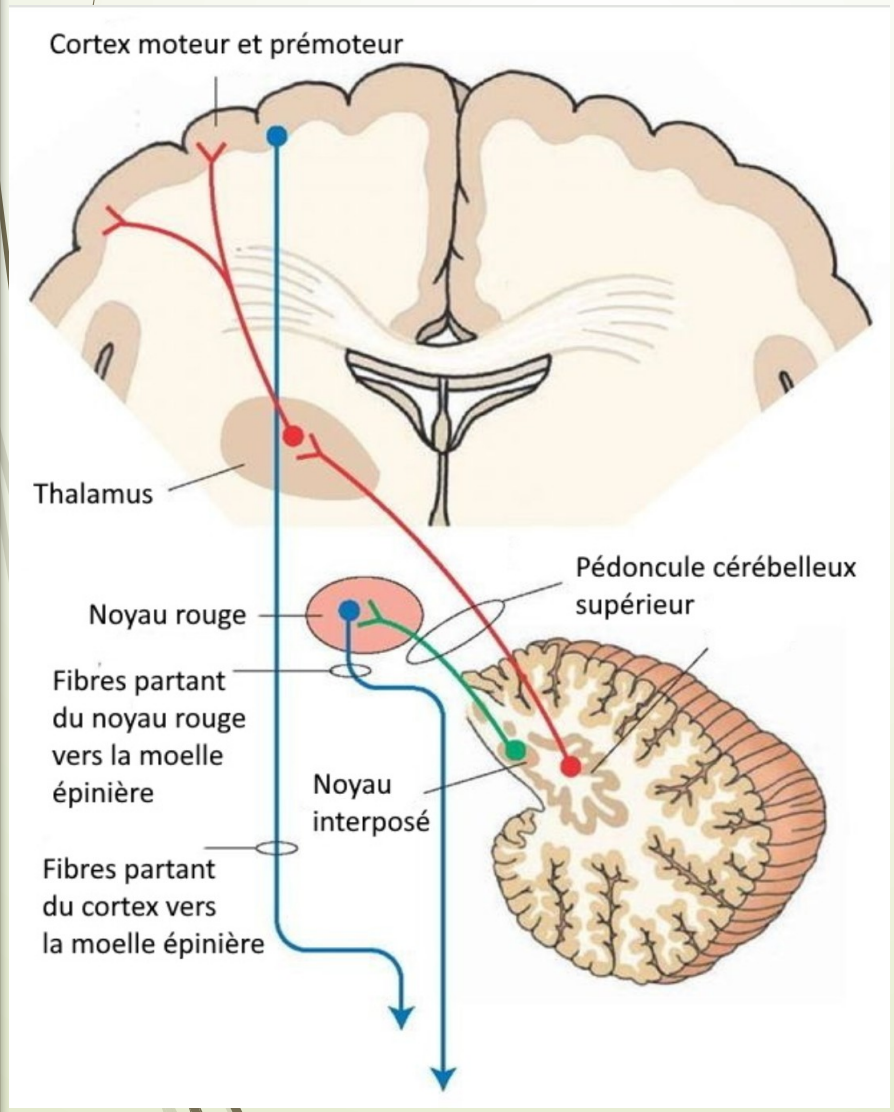
- Toute atteinte du cervelet est une perte de la capacité à coordonner et à exécuter les mouvements volontaires mais avec conservation de la force musculaire.

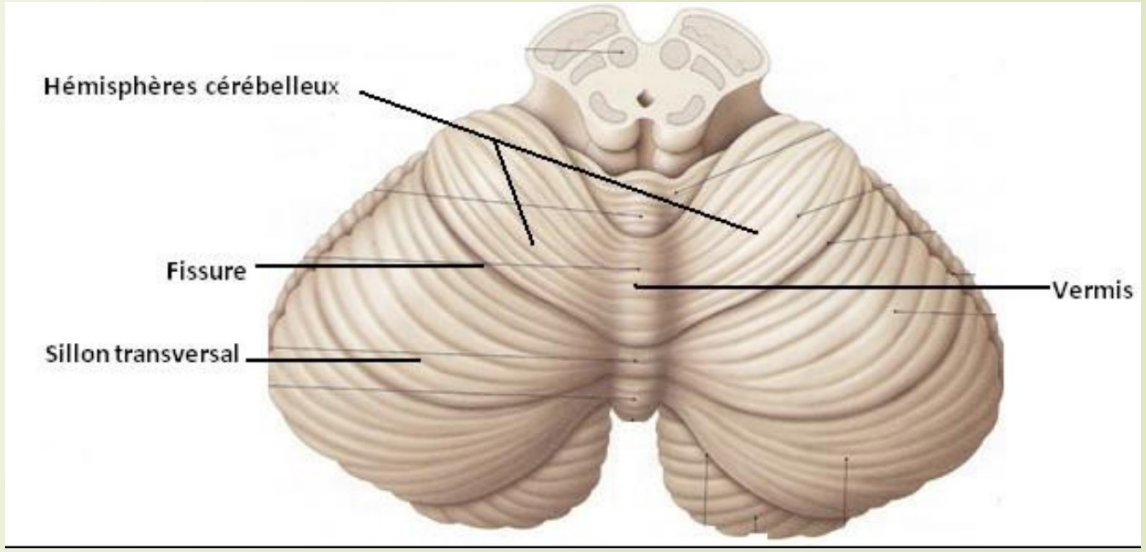
- Le cervelet joue un grand rôle dans l'ajustement des postures (syndrome cérébelleux statique) et dans l'exécution des mouvements volontaires (syndrome cérébelleux cinétique).

RAPPEL ANATOMIQUE



RAPPEL ANATOMIQUE





SEMIOLOGIE

- **Troubles de l'équilibre et de la marche : ATAXIE CEREBELLEUSE**

Le malade debout tend à écarter les pieds : élargissement du polygone de sustentation. Les pieds étant joints, des oscillations en tous sens apparaissent, non ou peu aggravées par l'occlusion des yeux (il n'existe pas de signe de Romberg).

Dans les formes mineures, on peut observer une contraction incessante des tendons des jambiers antérieurs : « danse des tendons ».

La démarche se fait aussi avec élargissement du polygone de sustentation, les bras écartés du tronc, les enjambées sont irrégulières, les pieds sont jetés trop haut, entraînant des embardées.

La démarche est ébrieuse (elle rappelle celle d'un homme ivre ou du petit enfant faisant ses premiers pas).

SEMIOLOGIE

- **Troubles de l'exécution du mouvement finalisé :**

Dans l'épreuve du doigt sur le nez, du talon sur la rotule : la direction du mouvement est conservée, mais le but est dépassé, il s’agit d'une dysmétrie avec hypermétrie.

SEMIOLOGIE

- **Asynergie** :

perte de la réaction posturale automatique habituellement associée au mouvement volontaire.

démontrée par les manœuvres suivantes :

Flexion de la cuisse et du tronc, on demande au sujet allongé, bras croisés de s’asseoir, il ne peut le faire, car ses MI restent fixés au plan du lit, il ne peut s’asseoir que lors qu'on maintient ses membres inférieurs soulevés.

Lors de l’accroupissement : le sujet ne décolle pas ses talons du sol.

Lors de l’inclinaison latérale du tronc, les pieds écartés, le sujet ne soulève pas le talon du coté opposé au déplacement .

Si on pousse doucement le sujet debout vers l’arrière, il chute sans compenser la poussée avec les bras, si on le pousse en avant, il ne fléchit pas les genoux.

SEMIOLOGIE

- **Adiadococinésie** :

est la difficulté ou l’impossibilité d’exécuter les mouvements alternatifs rapides à l’épreuve de marionnettes (pronation - supination rapidement alternées) ou de retourner les mains sur les cuisses ou battre la mesure avec les pieds (le mouvement est plus en plus maladroit et irrégulier).

- **Dyschronométrie** :

retard au déclenchement du mouvement et son arrêt.

SEMIOLOGIE

- **Hypotonie**

L'amplitude des mouvements imprimés aux membres par l'examinateur est augmentée : au niveau des mains, lorsqu'on imprime des mouvements de rotation alternatifs sur le tronc du malade, au niveau des pieds, sur le malade allongé.

Les réflexes rotuliens peuvent être pendulaires (sur le malade assis, jambes pendantes, après percussion du tendon rotulien, la jambe oscille comme un pendule)

Troubles de la parole et de l'écriture

La dysarthrie cérébelleuse : L'élocution est laborieuse, ralentie, scandée, explosive, irrégulière dans son volume et son débit.

La dysgraphie est la résultante de l'hypermétrie, dyschronométrie (lenteur), adiadococinésie (difficulté d'enchainement) et asynergie (malposition de la main et/ou avant-bras). .

SEMIOLOGIE

- **Tremblement cérébelleux:** est intentionnel de grande amplitude, qui commence avec le mouvement et s’exagère lors de l’exécution, il est exagéré par l’émotion, il peut être associé au tremblement d’attitude, ce tremblement disparait **au repos**.

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

- Il n'y a pas d'examen complémentaire électrophysiologique permettant de confirmer l'existence d'un syndrome cérébelleux.
- En revanche, l'imagerie cérébrale (scanner ou IRM) peut mettre en évidence une lésion du cervelet ou de ses pédoncules. Cette imagerie vise donc autant le diagnostic positif que le diagnostic étiologique.

ETIOLOGIES

- **Syndromes malformatifs :**

Agénésies et hypoplasies du cervelet: Syndrome de Joubert, Atrophie primitive de la couche des grains ; Hypoplasie cérébelleusecongénitales liée à l’X : Anomalie de Dandy-Walker, Malformation de Chiari, Malformation de la charnière occipito-atloïdienne

- **Traumatismes :** Les traumatismes occipitaux, avec ou sans fracture.

ETIOLOGIES

- **Affections vasculaires :**

L’hématome cérébelleux et l’Infarctus

- **Tumeurs :** Le syndrome cérébelleux sera statique dans les tumeurs vermiennes, cinétique dans les tumeurs lobaires. les médulloblastome, l’astrocytome du cervelet, les métastases : Les lymphomes (SIDA) , Les gliomes infiltrant du tronc cérébral , L’hémangioblastome

Les tumeurs de l’angle ponto-cérébelleux, rarement des méningiomes, surtout les neurinomes vestibulaires

ETIOLOGIES

- **Infections :**

une cérébellite peut compliquer une maladie infectieuse.

- **Maladies inflammatoires :**

La sclérose en plaques, La maladie cœliaque, La maladie de Behçet, le lupus érythémateux disséminé et la maladie de Wegener

ETIOLOGIES

- **Atrophies cérébelleuses :**

Atrophies cérébelleuses congénitales

Atrophies cérébelleuses secondaires :

Toxiques: alcool, métaux lourds, solvants

Médicamenteuse: La diphénylhydantoine et la carbamazépine, chimiothérapie anti-cancéreuse

L'ESSENTIEL A RETENIR

- **Syndrome cérébelleux statique** : ATAXIE CÉRÉBELLEUSE élargissement du polygone de sustentation marche ébrieuse danse des tendons.
- **Syndrome cérébelleux cinétique:** DADA.